



Lampiran : Dua berkas

Hal : Rekomendasi Hasil Audit Medis TKMKB Tahun 2024
Kasus Pneumonia dan Ventilator

Yth.

Direktur/ Kepala FKRTL Mitra BPJS Kesehatan Kantor Cabang Malang
di
Malang Raya

Pertama-tama kami manajemen BPJS Kesehatan Cabang Malang menyampaikan terimakasih atas dukungannya terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan audit medis yang telah dilaksanakan oleh Tim Kendali Mutu Kendali Biaya (TKMKB) Tingkat Pusat bersama Organisasi Profesi/Perhimpunan Profesi, Tim Kendali Mutu Kendali Biaya (TKMKB) Tingkat Provinsi dan Tim Kendali Mutu Kendali Biaya (TKMKB) Tingkat Cabang maka berdasarkan hasil audit medis terdapat temuan-temuan dan rekomendasi perbaikannya. Berkaitan dengan hal tersebut bersama ini disampaikan Rekomendasi Hasil Audit Medis TKMKB Tahun 2024 Kasus Pneumonia dan Ventilator sebagaimana terlampir. Sedangkan hal-hal yang menjadi perhatian sebagai berikut:

1. Penjaminan Kasus Pneumonia

- a. Tata laksana pneumonia pada dewasa harus disesuaikan dengan Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) Tata Laksana Pneumonia pada Dewasa Nomor HK.01.07/MENKES/2147/2023, yang memuat ketentuan:
 - 1) Penegakan diagnosis pneumonia
 - 2) Pemeriksaan penunjang untuk penegakan pneumonia
 - 3) Penilaian derajat keparahan penyakit dan penentuan indikasi rawat jalan atau rawat inap
 - 4) Pemilihan dan penggunaan antibiotik
- b. Ketentuan penjaminan manfaat kasus pneumonia meliputi:
 - 1) Penegakan diagnosis pneumonia harus berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang (radiologi, laboratorium, dll.), dan lainnya sesuai dengan PNPK dan/atau pedoman yang berlaku.

Kantor Cabang Utama Malang

Jl. Raden Tumenggung Suryo 44 Malang
Telp. +62 341 493026
Fax. +62 341 493802
www.bpjs-kesehatan.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

- 2) Diagnosis utama dan diagnosis sekunder harus sesuai dengan perjalanan penyakit pasien dan terapi yang dilakukan.
 - 3) Indikasi rawat jalan atau rawat inap pasien pneumonia pada dewasa harus berdasarkan sistem skoring CURB-65 atau PSI. Hasil skoring tersebut dilampirkan sebagai persyaratan klaim.
 - 4) Pemberian dan evaluasi 3 antibiotik pada pasien pneumonia yang dirawat paling cepat dilakukan dalam 72 jam.
 - 5) Pasien pneumonia yang dirawat inap dilakukan pemeriksaan mikrobiologi sputum (Kultur sputum atau gram sputum). Hal ini diperlukan untuk mencegah anti *microbial resistance*.
- c. Ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia serta sarana prasarana berdasarkan ketentuan yang berlaku. Hal ini perlu dipastikan agar pelayanan kesehatan dapat diselesaikan tanpa pemberian rujukan yang seharusnya tidak diperlukan ke fasilitas kesehatan lain. Pemenuhan kriteria ruang perawatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit.
2. Penjaminan Tindakan Ventilator
- a. Kriteria indikasi pemasangan ventilator harus jelas sesuai indikasi medis dan harus tergambar dalam catatan medis. Indikasi penggunaan ventilator/ ventilasi mekanis berdasarkan Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Anestesiologi dan Terapi Intensif Nomor HK.01.07/MENKES/1541/2022, terdiri dari:
 - 1) Gagal napas (Peringkat bukti Ic, derajat rekomendasi A)
 - a) Apnea/ henti napas
 - b) Inadekuat ventilasi
 - c) Inadekuat oksigenasi
 - 2) Insufisiensi fungsi respirasi dengan gagal tumbuh kembang
 - 3) Insufisiensi kardiak/syok
 - 4) Disfungsi neurologis
 - 5) Hipoventilasi sentral/ frequent apnea
 - 6) Penurunan kesadaran/ GCS ≤ 8
 - 7) Ketidakmampuan mempertahankan jalan napas (Peringkat bukti Ic, derajat rekomendasi A)
 - b. Pelayanan tindakan ventilator harus memperhatikan hal-hal berikut:
 - 1) Tindakan dilakukan sesuai dengan indikasi medis termasuk memastikan hasil pemeriksaan penunjang dan berdasarkan hasil pemeriksaan penunjang tersebut membutuhkan segera tindakan ventilator untuk menyelamatkan nyawa pasien (seperti Glasgow Coma Scale/ GCS ≤ 8 , hasil Analisis Gas Darah Arteri/ AGDA yang dilakukan sebelum dan setelah intubasi/ pemasangan ventilator, Early Warning System/ EWS), serta penanganan source control sesuai dengan

diagnosis utama pasien.

- 2) Monitoring ventilator harus lengkap termasuk mencantumkan Mode Ventilator dalam CPPT/ lembar monitoring pasien ICU (termasuk PEEP, FiO2, SIMV, dll.) sehingga menggambarkan kondisi perkembangan pasien yang sebenarnya. Harus menjadi perhatian bahwa perkembangan catatan kesehatan antara satu pasien dengan pasien lain unik/berbeda sehingga perlu dicek catatan perkembangan pasien khususnya selama memakai ventilator.
 - 3) Ketersediaan/ rasio dan kompetensi SDM dan sarana prasarana (tidak terbatas di ruang IGD dan ICU, termasuk di ruang perawatan), sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemenuhan kriteria ruang perawatan berdasarkan Peraturan Menteri kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit.
- c. Laporan penyebab kematian pasien pada surat kematian harus tertuang dalam rekam medik disertai laporan hasil audit kematian yang sudah dilaporkan ke Dinas Kesehatan.
 - d. Dalam upaya penanganan di ICU secara komprehensif, harus dipastikan ada tim *code blue* sesuai ketentuan.
3. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi panduan dalam kendali mutu pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala Cabang



Roni Kurnia Hadi Permana

Tembusan: Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Malang dan Kota Batu.

AN/de/pk00



TIM KENDALI MUTU DAN KENDALI BIAYA JKN TINGKAT PUSAT

Nomor : 37/TKMKBPUSAT/102024
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Rekomendasi Hasil Audit Medis Tahun 2024
Tema Pneumonia

Jakarta, 21 Oktober 2024

Yth. Direktur Utama
BPJS Kesehatan
di
Jakarta

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan audit medis tema pneumonia yang telah dilaksanakan oleh Tim Kendali Mutu Kendali Biaya (TKMKB) Tingkat Pusat bersama Organisasi Profesi/Perhimpunan Profesi, Tim Kendali Mutu Kendali Biaya (TKMKB) Tingkat Provinsi dan Tim Kendali Mutu Kendali Biaya (TKMKB) Tingkat Cabang maka berdasarkan hasil audit medis terdapat temuan-temuan dan rekomendasi perbaikannya. Berkaitan dengan hal tersebut bersama ini terlampir disampaikan rekomendasi dari TKMKB Pusat.

Semoga rekomendasi yang disampaikan ini dapat bermanfaat untuk BPJS Kesehatan dan pemangku BPJS Kesehatan untuk meningkatkan kendali mutu dan kendali biaya. Impelementasi dari rekomendasi ini diharapkan ada monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara periodik.

Demikian rekomendasi ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua TKMKB Tingkat Pusat

(Prof. dr. Adang Bachtiar, M.P.H, D.Sc)

Tembusan:

1. Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan – BPJS Kesehatan
2. Deputi Direksi Bidang Kebijakan Penjaminan Manfaat – BPJS Kesehatan
3. Ketua PB PAPDI
4. Ketua PP PDPI
5. Ketua PP IDAI
6. TKMKB Provinsi di Seluruh Indonesia
7. TKMKB Cabang di Seluruh Indonesia

REKOMENDASI HASIL AUDIT MEDIS
TEMA PNEUMONIA
TKMKB PUSAT

Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB) Tingkat Pusat bersama Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya Tingkat Provinsi, Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya Tingkat Cabang, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), dan Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) telah melakukan audit medis kasus pneumonia pada Tahun 2024. Bersama ini disampaikan rekomendasi hasil audit medis atas kasus pneumonia sebagai berikut:

I. Temuan Hasil Audit Medis

1. Aspek Medis

- a. Penegakan diagnosis pneumonia belum sesuai PNPK Tata Laksana Pneumonia pada Dewasa Nomor HK.01.07/MENKES/2147/2023, hanya dari klinis, sebagian belum terbukti dari gambaran radiologi maupun kultur atau pemeriksaan tambahan lainnya. Terdapat kasus yang belum jelas terdiagnosis pneumonia, namun didiagnosis pneumonia (baik sebagai diagnosis utama maupun diagnosis sekunder).
- b. Pada penelusuran RM, terdapat pada beberapa status pasien dirawat bukan karena pneumonia, namun pada resume medis diagnosis utama (DU) nya pneumonia. Terdapat juga pasien yang dirawat untuk operasi kecil, namun terdapat diagnosis pneumonia padahal dikonsulkan ke Sp. PD hanya sebagai toleransi operasi. Selain itu terdapat pasien yang dirawat karena edema paru, CKD overload, anemia gravis dengan tata laksana utama HD, transfusi, intra HD, furosemide, namun DU pulang adalah pneumonia.
- c. Pasien rawat inap dengan diagnosis pneumonia/bronchopneumonia, namun tidak ditemukan adanya pemenuhan kriteria untuk penentuan rawat inap berdasarkan CURB-65 atau PSI sebagaimana dalam PNPK Nomor

HK.01.07/MENKES/2147/2023 tentang Tata Laksana Pneumonia pada Dewasa.

- d. Standar Prosedur Operasional (SPO) pneumonia dewasa tidak mengacu pada PNPK Nomor HK.01.07/MENKES/2147/2023 tentang Tata Laksana Pneumonia pada Dewasa dalam menilai derajat keparahan penyakit pneumonia.
- e. Standar Prosedur Operasional (SPO) Pneumonia Dewasa tidak dilengkapi dengan pemeriksaan mikrobiologi (gram/kultur sputum) sebelum diberikan terapi empirik sebagaimana dalam PNPK Nomor HK.01.07/MENKES/2147/2023 tentang Tata Laksana Pneumonia pada Dewasa.
- f. Belum ada alur penegakan diagnosis dan alur tata laksana pneumonia dewasa dan pneumonia anak yang dapat dipahami oleh semua.
- g. *Clinical Pathway/ CP* yang ada belum diimplementasikan di semua unit. CP dan PPK belum sesuai dengan PNPK.
- h. Tingginya kasus diagnosis pneumonia dewasa (dan pneumonia anak) yang dirawat inap kurang dari 3 hari, kriteria rawat inap tidak sesuai dengan PNPK Nomor HK.01.07/MENKES/2147/2023 tentang Tata Laksana Pneumonia pada Dewasa. Pemantauan terhadap pasien dengan kasus lama rawat inap 1-2 hari dinilai masih kurang. Dalam CP dan PPK yang ada di RS, lama rawat kasus pneumonia adalah 7 hari.
- i. Terdapat kasus penurunan kesadaran dengan hasil rontgen pneumonia dan dilakukan rawat inap selama 11 jam lalu dirujuk dengan catatan sebagai pulang paksa.
- j. Pemberian antibiotika pada kasus pneumonia belum sesuai dengan PNPK, terapi antibiotik pada kasus pneumonia sesuai dengan PNPK adalah ceftriaxone digabung dengan macrolide/ aminoglikosida.
- k. Terdapat kasus pneumonia dewasa dengan pemberian antibiotik *intra vena* hanya 1 hari.
- l. Terdapat kasus pneumonia yang dirawat inap selama 7 jam dengan pemberian antibiotika tablet, bukan *intra vena*.

- m. Terdapat kasus pasien yang sudah perburukan (hasil EWS: 7), namun tidak masuk ICU.
- n. Hasil rontgen dikatakan (broncho)pneumonia, tetapi ketika dilihat foto basah tidak memenuhi gambaran sebagai pneumonia. Belum jelas diagnosis pneumonia tetapi didiagnosis sebagai pneumonia.
- o. Terdapat kasus pada pasien yang saat masuk didiagnosis dengan tonsilektomi, lalu dilakukan rontgen dan dinilai sebagai pneumonia, setelahnya diagnosis menjadi bronkopneumonia. Pasien dirawat selama 2 hari dan diminta kontrol. Saat kontrol penilaian kondisi utama, baik.
- p. Terdapat kasus dengan Surat Perintah Rawat Inap (SPRI) Diare, lalu dilakukan rontgen dan dinilai sebagai pneumonia, setelahnya diagnosis menjadi bronkopneumonia.
- q. Terdapat kasus bronkopneumonia dengan sepsis yang dirawat inap selama 37 jam (kurang dari 2 hari) dengan catatan kondisi pulang sebagai pulang sehat.

Penegakan diagnosis pneumonia hanya melihat klinis tidak ditunjang dengan pemeriksaan lainnya sesuai ketentuan untuk memastikan diagnosis pneumonia.
- r. Belum ada prosedur konsul DPJP untuk memastikan *patient safety* seperti harus dilakukan rawat inap bersama.

2. Manajerial

- a. Belum ada Tim pencegahan kecurangan JKN di internal Rumah Sakit sehingga belum berjalannya *Plan Do Study Action* (PDSA) dalam konteks melihat potensi fraud.
- b. Standar Prosedur Operasional (SPO) pneumonia tidak sesuai dengan penulisan tata naskah, tidak ada nomor dokumen, tidak ada logo Rumah Sakit dan tidak ada tanda tangan yang disahkan oleh Direktur Rumah Sakit.
- c. Penanganan keluhan belum optimal, *google review* rating 3,5

3. Kapasitas SDM Pelaksana dan Sarana Prasarana

- a. Staf khusus untuk melakukan analisis data belum ada.
- b. Jumlah perawat untuk pelayanan rawat inap masih kurang.

- c. *Clinical Pathway* (CP) belum diimplementasikan dengan baik. Kurangnya kepatuhan terdapat pelaksanaan Panduan Praktik Klinik (PPK) dan *Clinical Pathway* (CP) pneumonia diantaranya lama hari rawat, pemberian antibiotik, pemeriksaan penunjang medis.
 - d. Kemampuan Audit Medis Rumah Sakit masih terbatas.
 - e. *Awareness* potensi fraud masih kurang.
4. Sistem Informasi
- a. Pada sampel rekam medis yang diperiksa saat audit medis, resume medis tidak lengkap diisi penunjang, riwayat penyakit dahulu dan tata laksana selama perawatan. Dari sampel rekam medis juga ditemukan tidak adanya tanggal masuk dan tanggal keluar pasien.
 - b. Pada sampel rekam medis, terdapat ketidaksinkronan antara rekam medis/ resume medis dengan penagihan yang diajukan.
 - c. Pada sampel rekam medis formulir asesmen awal triase tidak berkaitan dengan asesmen rawat inap di CPPT.
 - d. Informasi waktu/jam di CPPT serta nama dan tanda tangan DPJP tidak lengkap.
 - e. Adanya status pulang yang berbeda antara rekam medis dengan data pengajuan cara pulang pasien, misalnya di rekam medis tertulis meninggal namun pengajuan cara pulang tertulis sehat.

II. Rekomendasi Medis

Rekomendasi medis atas hasil pelaksanaan audit medis kasus pneumonia sebagai berikut:

1. Tata laksana pneumonia harus disesuaikan dengan Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) Tata Laksana Pneumonia pada Dewasa Nomor HK.01.07/MENKES/2147/2023 dan Buku Panduan Pelayanan Neonatal UKK Neonatologi PP IDAI.
2. Diagnosis pneumonia harus berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisis, pemeriksaan penunjang (radiologi, laboratorium, dll.), dan lainnya sesuai dengan PNPK dan/atau pedoman yang berlaku. Bukti hasil pemeriksaan klinis dan penunjang harus jelas, memiliki keterhubungan yang dapat memastikan diagnosis akhir.

3. Diagnosis pasti pneumonia ditegakkan jika pada pemeriksaan radiologi ditemukan infiltrat baru atau progresif/ opasitas/ konsolidasi/ air *bronchogram* ditambah dengan awitan akut dari beberapa gejala dan tanda. Berikut merupakan gejala pneumonia:
 - a. Batuk
 - b. Nyeri dada
 - c. Sesak napas
 - d. Perubahan karakteristik sputum/ purulent
 - e. Suhu tubuh $\geq 38^{\circ}\text{C}$ (aksila)/riwayat demam
 - f. Pada pemeriksaan fisis dapat ditemukan tanda-tanda konsolidasi, suara napas bronkial dan ronki.
 - g. Jumlah leukosit ≥ 10.000 sel/ μL atau < 4500 sel/ μL dengan peningkatan neutrofil batang atau *immature granulocytes*.
4. Sesuai dengan PNPK Nomor HK.01.07/MENKES/2147/2023 tentang Tata Laksana Pneumonia pada Dewasa, penanganan kasus pneumonia harus disertai pemeriksaan gram atau kultur bakteri untuk memastikan terapi yang tepat dalam penanganannya.
5. Pemeriksaan fisis pada neonatus, salah satunya ditandai adanya tanda-tanda gawat nafas, melalui skor Downe.

Pemeriksaan	Skor Downe		
	1	2	3
Frekuensi Nafas	<60/menit	60-80/menit	>80/menit
Retraksi	Tidak ada retraksi	Retraksi ringan	Retraksi berat
Sianosis	Tidak ada sianosis	Sianosis hilang dengan pemberian O_2	Sianosis walaupun diberi O_2
Suara Nafas	Suara nafas di kedua paru baik	Suara nafas di kedua paru menurun	Tidak ada suara nafas di kedua paru
Merintih	Tidak merintih	Dapat didengar dengan stetoskop	Dapat didengar tanpa alat bantu

Evaluasi:

Skor total ≤ 3 : gawat nafas ringan

Skor total 4-5: gawat nafas sedang

Skor total ≥ 6 : gawat nafas berat

Pemeriksaan penunjang pada neonatus diantaranya termasuk:

- Pemeriksaan darah lengkap
- Pemeriksaan analisis gas darah dan kultur darah, CRP (fasilitas lengkap)
- Rontgen dada: berupa infiltrat di lapang paru yang terkena
- Kultur bakteri

6. Diagnosis utama dan diagnosis sekunder harus sesuai dengan perjalanan penyakit pasien dan terapi yang dilakukan.
7. Setelah penegakan diagnosis pneumonia, dilanjutkan dengan kriteria CURB-65 atau PSI untuk menentukan indikasi rawat jalan atau rawat inap.
8. Penentuan pasien pneumonia pada dewasa dirawat jalan atau dirawat inap harus berdasarkan sistem skoring CURB-65 atau PSI.

Skor CURB-65

Confusion Uji mental $\leq$ nilai 8 $\rightarrow$ skor 1 Uji mental $>$ nilai 8 $\rightarrow$ skor 0
Ureum Ureum $>$ 40 mg/dL $\rightarrow$ skor 1 Ureum $\leq$ 40 mg/dL $\rightarrow$ skor 0
Respiratory Rate (RR) RR $>$ 30x/menit $\rightarrow$ skor 1 RR $\leq$ 30x/menit $\rightarrow$ skor 0
Blood pressure (BP) BP $<$ 90/60 mmHg $\rightarrow$ skor 1 BP $\geq$ 90/60 mmHg $\rightarrow$ skor 0

Umur
Umur $\geq$ 65 tahun $\rightarrow$ skor 1
Umur $<$ 65 tahun $\rightarrow$ skor 0

Penilaian berat pneumonia dengan menggunakan sistem skor CURB-65 adalah sebagai berikut:

- 1) Skor 0 – 1: risiko kematian rendah, pasien dapat berobat jalan.
- 2) Skor 2: risiko kematian sedang, dapat dipertimbangkan untuk dirawat.
- 3) Skor $\geq$ 3: risiko kematian tinggi dan dirawat harus ditata laksana sebagai pneumonia berat
- 4) Skor 4 atau 5: harus dipertimbangkan perawatan intensif

Pneumonia Severity Index (PSI)

Karakteristik Pasien	Nilai
Faktor demografik	
▪ Umur	
– Laki-Laki	Umur (tahun)
– Perempuan	Umur (tahun)-10
▪ Penghuni Panti Werda	+10
Penyakit komorbid	
▪ Keganasan	+30
▪ Penyakit hati	+20
▪ Penyakit jantung kongestif	+10
▪ Penyakit serebro vaskular	+10
▪ Penyakit ginjal	+10
Pemeriksaan fisis	
▪ Gangguan kesadaran	+20
▪ Frekuensi nafas >30 x/menit	+20
▪ Tekanan darah sistolik <90 mmHg	+20
▪ Suhu tubuh $<35^{\circ}\text{C}$ atau $>40^{\circ}\text{C}$	+15
▪ Frekuensi Nadi >125 x/menit	+10

Hasil laboratorium	
▪ PH < 7.35	+30
▪ Ureum > 64,2 mg/dL	+20
▪ Natrium < 130 mEq/L	+20
▪ Glukosa > 250 mg/dL	+10
▪ Hematokrit < 30%	+10
▪ Tekanan O2 darah arteri < 60 mmHg	+10
▪ Efusi pleura	+10

PSI digunakan untuk menetapkan indikasi rawat inap pneumonia komunitas.

- 1) Skor PSI lebih dari 70.
- 2) Bila skor PSI kurang dari 70, pasien tetap perlu dirawat inap bila dijumpai salah satu dari kriteria dibawah ini.
 - i. Frekuensi napas > 30 kali/menit
 - ii. PaO₂/FiO₂ kurang dari 250 mmHg
 - iii. Radiologi menunjukkan infiltrat/ opasitas/ konsolidasi multi lobus
 - iv. Tekanan sistolik < 90 mmHg
 - v. Tekanan diastolik < 60 mmHg.
- 3) Pneumonia pada pengguna NAPZA.

Total poin yang didapatkan dari PSI dapat digunakan untuk menentukan risiko, kelas risiko, angka kematian, dan jenis perawatan

Derajat Skor Risiko PSI

Total Poin	Risiko	Kelas Risiko	Angka Kematian	Perawatan
Tidak diprediksi	Rendah	I	0.1%	Rawat jalan
≤ 70		II	0.6%	Rawat jalan

71 - 90		III	2.8%	Rawat inap/ Rawat jalan
91 - 130	Sedang	IV	8.2%	Rawat inap
> 130	Berat	V	29.2%	Rawat inap

9. Hasil Skoring CURB-65 dan PSI dilampirkan sebagai persyaratan klaim.
10. Pasien pneumonia yang dirawat, pemberian dan evaluasi antibiotik paling cepat dilakukan dalam 72 jam sesuai Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Pneumonia pada Dewasa Nomor HK.01.07/MENKES/2147/2023 halaman 50.
11. Pasien pneumonia yang dirawat inap diperiksa pemeriksaan mikrobiologi sputum (Kultur sputum atau gram sputum sesuai kemampuan Lab RS) sesuai Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Pneumonia pada Dewasa Nomor HK.01.07/MENKES/2147/2023 halaman 13-14. Hal ini diperlukan untuk mencegah *anti microbial resistance*.
12. Penulisan rekam medis harus dapat dipastikan memberikan gambaran yang jelas tentang pasien secara individu yang unik (bukan individu yang sama antara satu pasien dengan pasien lainnya), mulai dari data umum, hasil pemeriksaan awal, proses penegakan diagnosis, penegakan diagnosis berdasarkan hasil pemeriksaan penunjang yang terhubung dengan penilaian klinis, dan lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk resume medis dan cara pulang pasien yang dapat menggambarkan secara jelas kebenaran diagnosis yang ditegakkan.

III. Rekomendasi kepada Instansi/Pemangku Kepentingan

Rekomendasi yang disusun antara lain sebagai berikut:

1. Untuk Rumah Sakit
 - a. harus memiliki Panduan Praktik Klinis (PPK) dan *Clinical Pathway* (CP) untuk semua penyakit yang ditanganinya, minimal untuk 20 penyakit terbanyak yang ditangani pada saat awal bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
 - b. harus melakukan reviu/ perbaikan/ penyempurnaan Panduan Praktik Klinis (PPK) dan *Clinical Pathway* (CP), tidak terbatas untuk

Pneumonia, agar sesuai dengan Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) atau ketentuan yang berlaku.

- c. harus dipastikan memiliki program audit medis internal oleh Komite Medis dan Kelompok Staf Medis (KSM) terhadap kasus *high volume*, *high risk* serta meningkatkan peran dan fungsi tim anti *fraud* dan terus meningkatkan program audit medis internal.
- d. harus memastikan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bagian dalam menjaga mutu pelayanan kesehatan. Dalam Perjanjian Kerja Sama, harus ditegaskan dengan jelas tidak bersifat umum.
- e. harus meningkatkan kepatuhan pelaksanaan PPK dan CP melalui audit kepatuhan oleh Tim Mutu RS.
- f. harus memastikan sinergi dan koordinasi antar bagian dalam upaya memastikan mutu layanan termasuk melakukan audit medis mandiri
- g. harus memastikan kelengkapan pengisian rekam medis dan melaksanakan rekam medis elektronik sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Untuk Organisasi Profesi/Perhimpunan Profesi

- a. Melakukan penguatan kapasitas anggota secara periodik dan terukur dalam rangka menjaga dan memastikan mutu pelayanan kesehatan, termasuk memastikan pengisian rekam medis yang lengkap dan benar.
- b. Melakukan revidi terhadap standar pelayanan medik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Untuk Asosiasi Fasilitas Kesehatan (PERSI, ARSADA dan/atau ARSSI)

- a. Memastikan kapasitas anggotanya secara terukur dalam menjaga mutu layanan kesehatan sesuai ketentuan, termasuk memastikan pengisian resume medis yang lengkap dan benar sebagai dokumen autentik yang dapat dipertanggungjawabkan dan dikoordinasikan dengan pemangku kepentingan.

- b. Memastikan anggotanya memenuhi sumber daya manusia dan sarana prasarana sesuai ketentuan yang berlaku, salah satunya pemenuhan kriteria ruang perawatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit.
4. Untuk TKMKB Provinsi dan Cabang
- a. Harus aktif meminta kepada BPJS Kesehatan dalam proses monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap proses penjaminan mutu layanan dan memastikan efektifitas pembiayaan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, termasuk dalam menindaklanjuti hasil-hasil audit medis baik internal maupun dari TKMKB Pusat.
 - b. Melakukan validasi terhadap perbaikan mutu layanan pasca pelaksanaan audit medis.
 - c. Melakukan *feedback* pelaksanaan audit medis yang melibatkan pemangku kepentingan (RS, BPJS Kesehatan, Organisasi Perhimpunan, Asosiasi Faskes, dll).
5. Untuk Dinas Kesehatan Provinsi dan Kota/Kabupaten
- a. Memastikan pelayanan kesehatan yang bermutu serta berjalan secara efektif dan efisien untuk memastikan keberlanjutan program Jaminan Kesehatan.
 - b. Memperkuat fungsi monitoring evaluasi serta pembinaan kepada fasilitas kesehatan dalam upaya implementasi mutu layanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku, secara periodik dan terukur.
 - c. Menyediakan dan memastikan fasilitas pemeriksaan yang merata untuk pemeriksaan mikrobiologi/ kultur.
6. Untuk BPJS Kesehatan Wilayah dan Cabang
- a. Harus dapat memastikan proses kredensialing dan/atau proses re-kredensialing mendapatkan fasilitas kesehatan yang dapat

memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar mutu dan layanan yang ditetapkan oleh Undang-Undang, termasuk dipastikan pelayanan kesehatan dapat diselesaikan tanpa pemberian rujukan ke fasilitas kesehatan lain.

- b. Menyampaikan rekomendasi TKMKB kepada manajemen RS dan memastikan terlaksananya rekomendasi tersebut dengan memastikan diketahui oleh komite medik.
- c. BPJS Kesehatan Wilayah bersama dengan BPJS Kesehatan Cabang melakukan evaluasi bersama TKMKB Provinsi dan TKMKB Cabang dan/atau pemangku kepentingan lainnya pada kesempatan pertama setelah rekomendasi ini diterima dan melaporkan hasilnya kepada BPJS Kesehatan Pusat melalui Kedeputan Bidang Kebijakan Penjaminan Manfaat.
- d. Melakukan validasi terhadap perbaikan mutu layanan pasca pelaksanaan audit medis.
- e. Komunikasi intensif perlu dibangun melalui rapat koordinasi berbasis data sehingga tercipta *early warning system* yang dilakukan maksimal 3 (tiga) bulan sekali melalui *utilization review* bersama dengan Rumah Sakit, TKMKB dan Dinas Kesehatan dengan melibatkan BPJS Kesehatan.
- f. Melakukan *feedback* pelaksanaan audit medis yang melibatkan pemangku kepentingan (RS, BPJS Kesehatan, Organisasi Perhimpunan, Asosiasi Faskes, dll).
- g. Memastikan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan kepada fasilitas kesehatan berjalan efektif dan terukur.



TIM KENDALI MUTU DAN KENDALI BIAYA JKN TINGKAT PUSAT

Nomor : 36/TKMKBPUSAT/102024
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Rekomendasi Hasil Audit Medis Tahun 2024
Tema Ventilator

Jakarta, 21 Oktober 2024

Yth. Direktur Utama
BPJS Kesehatan
di
Jakarta

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan audit medis tema ventilator yang telah dilaksanakan oleh Tim Kendali Mutu Kendali Biaya (TKMKB) Tingkat Pusat bersama Organisasi Profesi/Perhimpunan Profesi, Tim Kendali Mutu Kendali Biaya (TKMKB) Tingkat Provinsi dan Tim Kendali Mutu Kendali Biaya (TKMKB) Tingkat Cabang maka berdasarkan hasil audit medis terdapat temuan-temuan dan rekomendasi perbaikannya. Berkaitan dengan hal tersebut bersama ini terlampir disampaikan rekomendasi dari TKMKB Pusat.

Semoga rekomendasi yang disampaikan ini dapat bermanfaat untuk BPJS Kesehatan dan pemangku BPJS Kesehatan untuk meningkatkan kendali mutu dan kendali biaya. Implementasi dari rekomendasi ini diharapkan ada monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara periodik.

Demikian rekomendasi ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua TKMKB Tingkat Pusat

(Prof. dr. Adang Bachtiar, M.P.H, D.Sc)

Tembusan:

1. Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan – BPJS Kesehatan
2. Deputi Direksi Bidang Kebijakan Penjaminan Manfaat – BPJS Kesehatan
3. Ketua PB PAPDI
4. Ketua PP PDPI
5. Ketua PP PERDATIN
6. TKMKB Provinsi di Seluruh Indonesia
7. TKMKB Cabang di Seluruh Indonesia

REKOMENDASI HASIL AUDIT MEDIS
TEMA VENTILATOR/ VENTILASI MEKANIK
TKMKB PUSAT

Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB) Tingkat Pusat bersama Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya Tingkat Provinsi, Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya Tingkat Cabang, Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia (PERDATIN), Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), dan Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) telah melakukan audit medis kasus ventilator/ventilasi mekanik pada Tahun 2024. Bersama ini disampaikan rekomendasi hasil audit medis atas kasus ventilator/ventilasi mekanik sebagai berikut:

I. Temuan Hasil Audit Medis

1. Aspek Medis

- a. Indikasi pemasangan ventilator belum tergambar secara spesifik, contoh terdapat pemeriksaan AGDA (analisis gas darah arteri) yang baru dilakukan setelah dipasang ventilator (intubasi jam 13.30; AGDA jam 18.44).
- b. Waktu dan kondisi pemeriksaan laboratorium (termasuk AGDA) saat diambil belum jelas (kapan diambil, kapan keluar).
- c. Adanya inkonsistensi antara hasil penilaian triase diantaranya nilai GCS 5 namun nilai skala nyeri 8, pada pencatatan EWS (*early warning system*) terlihat pencatatan yang tidak konsisten (inkonsisten).
- d. Monitoring ventilator belum lengkap. Pada lembar catatan pemeriksaan pasien di ICU tidak tergambar/tidak terlihat kondisi hemodinamik, terapi, dan kondisi pasien secara kontinu, yang terlihat hanya catatan modus ventilator yang relatif sama settingannya (PEEP/*positive end expiratory pressure*, FiO₂/PO₂, SIMV).
- e. *Source control* sebagai penyebab penyakit belum terintegrasi dengan tindakan yang dilakukan, contoh:

- i. Pasien datang dengan CKD (*chronic kidney disease*) Stage V, asidosis metabolik dan edema paru dilakukan intubasi namun tidak terlihat penanganan untuk mengatasi CKD-nya seperti HD, pemberian diuretik, koreksi elektrolit, atau lainnya.
- ii. Pasien dengan pendarahan *intracranial* tidak dilakukan operasi segera.
- iii. Pemasangan CVC (*central venous catheter*) pada kasus asidosis tidak segera dilakukan, seharusnya bisa dilakukan bersamaan/satu paket dengan intubasi.
- f. Penyebab *respiratory failure* tidak sesuai dengan indikasi kriteria *respiratory failure* sesuai dengan BA Kesepakatan Kemenkes sehingga tidak indikasi pemasangan ventilator.
- g. Beberapa kasus datang dari RS lain dengan kondisi berat, namun dokumentasi atau pencatatan terkait kondisi pasien baik pencatatan perawat ataupun dokter kurang lengkap sehingga kondisi perburukan yang terjadi pada pasien sulit dilacak sampai akhirnya dinyatakan meninggal.
- h. Penegakan diagnosis pada beberapa kasus yang tidak didukung pemeriksaan yang spesifik, contoh pada kasus meningitis: tidak terdapat trias meningitis, CT Scan tidak spesifik menyebutkan adanya infeksi, dan tidak ada pemeriksaan lumbal punksi untuk melakukan LCS (*liquor cerebro spinalis*).

2. Manajerial

- a. Tingginya angka kematian di ICU dengan LOS 1-2 hari dengan penggunaan ventilator (> 95% kasus meninggal dunia LOS 1-2 hari dengan penggunaan ventilator).
- b. Manajemen RS belum melakukan *utilization review* secara mandiri sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Permenkes Nomor 71 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional, Pasal 37.
- c. Audit kematian belum dilakukan dan angka kematian tidak dilaporkan secara rutin ke Dinas Kesehatan.
- d. Mutu dinilai masih *sub* standar (mutu pelayanan harus diperbaiki).

- e. Belum ada pertemuan reguler terkait evaluasi utilisasi ICU dan pemakaian ventilator oleh Tim Komite Mutu, Komite Medik, Casemix maupun Tim Anti Fraud.
 - f. Hasil revidu pasien (komplain pasien) di media sosial belum mendapat respon dan dibahas dalam agenda rapat manajemen secara rutin.
 - g. Keluhan pasien di media sosial belum ditindaklanjuti secara cepat oleh manajemen.
 - h. Sistem pembayaran insentif DPJP non bedah secara *fee for service* sedangkan DPJP bedah secara persentase.
3. Kapasitas SDM Pelaksana dan Sarana Prasarana
- a. Dokter umum yang menangani intensif care belum tersertifikasi, hanya pelatihan internal dan perawat yang tersertifikasi hanya 1 orang.
 - b. Rasio perawat dengan jumlah tempat tidur khususnya di ruang ICU belum ideal. Saat ini jumlah perawat total sebanyak 97 orang dan jumlah tempat tidur total sebanyak 387. Untuk jumlah perawat ICU sebanyak 19 orang (untuk 3 shift) dan jumlah tempat tidur ICU sebanyak 25 tempat tidur ICU atau rasio perawat ICU : tempat tidur ICU saat ini yaitu 1 perawat ICU : 4 tempat tidur ICU.
 - c. Ruang ICU kurang memenuhi syarat (jendela ICU terbuka, terlalu banyak kisi-kisi di ICU yang berpotensi menyimpan debu).
 - d. Ruang HCU kurang memenuhi syarat (*emergency call* tidak ada, kamar mandi belum sesuai).
 - e. Jarak antar bed belum sesuai ketentuan.
 - f. Pemeriksaan angka kuman (PPI) tidak dilakukan.
 - g. Belum ada sistem monitoring tersentral di *nurse station* ICU dan HCU.
4. Sistem Informasi
- a. Adanya inkonsistensi dalam pencatatan rekam medis, sebagai contoh terdapat perbedaan hasil asesmen saat di IGD dengan hasil asesmen oleh DPJP. Dengan kondisi ini dapat dinilai apakah kompetensi RS dengan diagnosis rujukan pasien kurang sesuai,

seharusnya pasien ditangani di RS lain yang memiliki kompetensi sesuai kondisi pasien.

- b. Rekam medis elektronik belum terintegrasi dengan catatan perkembangan pasien terintegrasi (CPPT).
- c. Lembar *informed consent* belum lengkap, contoh belum ditandatangani oleh keluarga pasien.
- d. Laporan tindakan intubasi dan pemasangan ventilator belum ada, masih memakai laporan tindakan bedah.
- e. Penyebab kematian tidak tertulis baik pada surat kematian maupun resume medis.

II. Rekomendasi Medis

Rekomendasi medis atas hasil pelaksanaan audit medis kasus ventilator/ventilasi mekanik sebagai berikut:

1. Kriteria indikasi pemasangan ventilator harus jelas sesuai indikasi medis dan harus tergambar dalam catatan medis.

Contoh pada kasus di RS yang dilakukan audit medis:

Indikasi pemasangan ventilator tidak dapat dipastikan penyebabnya, jika merujuk pada nilai AGDA yang menunjukkan ada atau tidaknya kegagalan napas, dari data yang didapatkan, pemeriksaan AGDA baru dilakukan 4 jam lebih setelah dilakukan intubasi untuk pemasangan ventilator seharusnya pemeriksaan AGDA dilakukan sebelum pemasangan ventilator yang mana hasil pemeriksaan menunjukkan ada atau tidaknya kegagalan napas yang membutuhkan tindakan pemasangan ventilator.

2. Indikasi (Peringkat bukti IV, derajat rekomendasi C) penggunaan ventilasi mekanis berdasarkan Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Anestesiologi dan Terapi Intensif Nomor HK.01.07/MENKES/1541/2022, terdiri dari:
 - a. Gagal napas (Peringkat bukti Ic, derajat rekomendasi A)
 - i. Apnea/henti napas
 - ii. Inadekuat ventilasi
 - iii. Inadekuat oksigenasi
 - b. Insufisiensi fungsi respirasi dengan gagal tumbuh kembang

- c. Insufisiensi kardiak/syok
 - d. Disfungsi neurologis
 - e. Hipoventilasi sentral/ *frequent apnea*
 - f. Penurunan kesadaran/ $GCS \leq 8$
 - g. Ketidakmampuan mempertahankan jalan napas (Peringkat bukti Ic, derajat rekomendasi A)
3. Harus dipastikan keterhubungan antara hasil pemeriksaan mulai dari awal masuk sampai akhir sehingga diyakini bahwa pasien memerlukan rawatan ventilator dan dirawat di ruang ICU. Dalam kasus di RS yang dilakukan audit medis perlu adanya keterhubungan hasil pemeriksaan di IGD (hasil triase) dengan hasil pemeriksaan yang dicatat dalam lembar catatan medis pasien di ICU termasuk dalam EWS dan perlu adanya pencatatan *real time* untuk mengantisipasi perburukan klinis pasien yang bisa berubah sewaktu-waktu.
 4. RS harus memiliki Standar Prosedur Operasional (SPO) dalam penanganan *source control* sesuai dengan diagnosis utama pasien.
Contoh pada RS yang dilakukan audit medis, apabila kondisi gagal napas disebabkan oleh gangguan metabolik (sebagai diagnosis utama) dan memerlukan tindakan segera dalam penyelamatan pasien untuk memastikan penanganan emergensi sesuai kondisi penyakit utama pasien, misal untuk memastikan proses respirasi optimal sehingga dilakukan tindakan intubasi terlebih dahulu, maka pasca tindakan tersebut penyebab utama gangguan napas karena gangguan metabolik harus dikoreksi sesuai ketentuan (PNPK/PPK/dan lainnya). Atau dilakukan tindakan penanganan emergensi sesuai kondisi penyakit utama pasien bersamaan dengan memastikan penanganan kondisi gagal nafasnya, misal pemasangan CVC atau *double lumen* saat intubasi secara bersamaan.
 5. Monitoring pasien dengan ventilator dalam CPPT/lembar monitoring pasien ICU (termasuk PEEP, FiO₂, SIMV, dll) harus lengkap tercatat sehingga menggambarkan kondisi perkembangan pasien yang sebenarnya.
 6. Harus dipastikan kompetensi SDM dan rasio SDM yang bertugas di RS sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak terbatas di ruang IGD dan

ICU termasuk di ruang perawatan. Kompetensi SDM dan rasio SDM yang tidak sesuai akan menurunkan mutu layanan.

III. Rekomendasi kepada Instansi/Pemangku Kepentingan

Rekomendasi yang disusun antara lain sebagai berikut:

1. Untuk Rumah Sakit

- a. harus melakukan *utilization review* secara mandiri sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Permenkes Nomor 71 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional, Pasal 37 dan harus lebih aktif berkomunikasi dengan BPJS Kesehatan sehingga jika ditemukan data anomali dapat segera ditindaklanjuti.
- b. harus memastikan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bagian dalam menjaga mutu pelayanan kesehatan
- c. harus membuat laporan kematian dan audit kematian serta dievaluasi oleh Tim Komite Mutu, Komite Medik, Casemix maupun Tim Anti Fraud dan disampaikan ke Dinas Kesehatan sebagai upaya pencegahan ke depan sehingga tidak terulang
- d. harus memastikan sinergi dan koordinasi antar bagian dalam upaya memastikan mutu layanan termasuk melakukan audit medis mandiri
- e. harus responsif menanggapi keluhan pasien/keluarga pasien yang diperoleh dari berbagai kanal (media sosial, surat kabar, dll) dan dibahas dalam agenda rapat manajemen secara rutin.
- f. harus memastikan sistem pembayaran kepada DPJP yang lebih efektif dan efisien yang tidak memicu memaksimalkan pendapatan secara tidak wajar.
- g. harus memastikan kelengkapan pengisian rekam medis sesuai ketentuan yang berlaku.
- h. harus melaksanakan rekam medis elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- i. harus memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan sarana prasarana sesuai standar ketentuan yang berlaku. Salah satu ketentuan dalam pemenuhan kriteria ruang perawatan berdasarkan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit.

- j. harus memastikan SDM yang bekerja memiliki kapasitas sesuai bidang tugasnya yang dibuktikan dengan adanya dokumen yang menyatakan keahlian sesuai bidang tugasnya (sertifikasi) sesuai ketentuan yang berlaku.
 - k. harus memastikan ketersediaan tim *code blue* untuk penanganan di ICU.
 - l. harus membuat dan/atau mereviu Standar Prosedur Operasional (SPO) atau Panduan Praktik Klinis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Untuk Organisasi Profesi/Perhimpunan Profesi
- a. Membuat kriteria indikasi pemasangan ventilator sebagai panduan fasilitas kesehatan dalam memastikan pemasangan ventilator sesuai ketentuan.
 - b. Melakukan penguatan kapasitas anggota secara periodik dalam rangka menjaga dan memastikan mutu pelayanan kesehatan, termasuk memastikan pengisian rekam medis yang lengkap dan benar.
3. Untuk Asosiasi Fasilitas Kesehatan (PERSI, ARSADA dan/atau ARSSI)
- a. Memastikan kapasitas anggotanya dalam menjaga mutu layanan kesehatan sesuai ketentuan, termasuk memastikan pengisian resume medis yang lengkap dan benar sebagai dokumen autentik yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. Memastikan anggotanya memenuhi sumber daya manusia dan sarana prasarana sesuai ketentuan yang berlaku, salah satunya pemenuhan kriteria ruang perawatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit.

4. Untuk TKMKB Provinsi dan Cabang
 - a. Melakukan *feedback* pelaksanaan audit medis yang melibatkan pemangku kepentingan (RS, BPJS Kesehatan, Organisasi Perhimpunan, assosiasi Faskes, dll).
 - b. Melakukan validasi terhadap perbaikan mutu layanan pasca pelaksanaan audit medis.
 - c. Aktif melakukan monitoring evaluasi terhadap proses penjaminan mutu layanan dan biaya RS.
5. Untuk Dinas Kesehatan Provinsi dan Kota/Kabupaten

Menguatkan fungsi monitoring evaluasi serta pembinaan kepada fasilitas kesehatan dalam upaya implementasi mutu layanan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk umpan balik pelaporan angka kematian, yang dilaporkan secara periodik (paling lama setiap semester) secara berjenjang ke Kementerian Kesehatan.
6. Untuk BPJS Kesehatan Wilayah dan Cabang
 - a. Menyampaikan rekomendasi TKMKB kepada manajemen RS dan memastikan terlaksananya rekomendasi tersebut dengan memastikan diketahui oleh komite medik.
 - b. BPJS Kesehatan Wilayah bersama dengan BPJS Kesehatan Cabang melakukan evaluasi bersama TKMKB Provinsi dan TKMKB Cabang dan/atau pemangku kepentingan lainnya pada kesempatan pertama setelah rekomendasi ini diterima dan melaporkan hasilnya kepada BPJS Kesehatan Pusat melalui Kedeputian Bidang Kebijakan Penjaminan Manfaat.
 - c. Melakukan validasi terhadap perbaikan mutu layanan pasca pelaksanaan audit medis.
 - d. Komunikasi intensif perlu dibangun melalui rapat koordinasi berbasis data sehingga tercipta *early warning system* yang dilakukan maksimal 3 (tiga) bulan sekali melalui *utilization review* bersama dengan Rumah Sakit, TKMKB dan Dinas Kesehatan dengan melibatkan BPJS Kesehatan.

- e. Memastikan proses kredensialing – rekredensialing bersama-sama dengan Dinas Kesehatan.
- f. Melakukan *feedback* pelaksanaan audit medis yang melibatkan pemangku kepentingan (RS, BPJS Kesehatan, Organisasi Perhimpunan, Asosiasi Faskes, dll).